Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJus)

NOTA TÉCNICA DO NATJUS Nº 1147/2026

Autos: 0806842-39.2026.8.12.0099 (fictício). Procedimento Comum Cível, Comarca de Vila Boa Esperança, 1ª Vara
Requerente: Valdirene Souza Prado. Requeridos: Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Vila Boa Esperança

I. Enfermidade e linha terapêutica do SUS

Segundo o laudo médico e os demais documentos, a requerente, na faixa de 40 a 50 anos, reside no município de Vila Boa Esperança/MS e tem Urticária Crônica Espontânea (CID-10 L50.1). Foram apresentados resultados de exames laboratoriais complementares.

Princípio ativo	Posologia	Incorporado ao SUS?
Omalizumabe	300 mg, via SC, a cada 4 semanas	SIM*

* O medicamento solicitado está incorporado para patologia/CID diferente da apresentada pela paciente.

A UCE caracteriza-se por urticas e/ou angioedema recorrentes por mais de seis semanas, sem fator desencadeante identificado, com prurido intenso, distúrbios do sono e repercussões emocionais. O diagnóstico é clínico.

II. Tratamentos realizados e alternativas

Segundo os documentos médicos, a paciente usou Bilastina em dose quadruplicada por mais de 4 meses, sem resposta clínica satisfatória, e foi orientada a evitar Dipirona e anti-inflamatórios não esteroides, usando Paracetamol em caso de dor ou febre. Não constam nos autos informações sobre outros tratamentos farmacológicos e não farmacológicos eventualmente realizados.

O tratamento é escalonado. A primeira linha são os anti-histamínicos H1 de segunda geração, iniciados na dose padrão e elevados até quatro vezes a dose habitual. Na falta de resposta, a segunda linha é o omalizumabe, anticorpo monoclonal anti-IgE indicado para UCE refratária aos anti-histamínicos. A terceira linha inclui imunossupressores, como a ciclosporina A, para casos graves e refratários, com monitorização rigorosa. Corticosteroides sistêmicos só nas exacerbações agudas, por curtos períodos; antagonistas de leucotrienos e outros imunossupressores são opções excepcionais, com evidência mais limitada.

III. O medicamento solicitado

O omalizumabe liga-se à IgE livre e reduz a ativação de mastócitos e basófilos. Indicações: asma alérgica persistente moderada a grave, rinossinusite crônica grave com pólipo nasal e urticária crônica espontânea refratária aos anti-histamínicos H1 em adultos e adolescentes acima de 12 anos. Na UCE, diminui o prurido e a atividade da doença. Eventos adversos

principais: cefaleia e reações no local da aplicação; raros e graves: anafilaxia, doença do soro, trombocitopenia grave e síndrome de Churg-Strauss. A manutenção deve ser reavaliada periodicamente (fonte: bula, ANVISA).

IV. Classe e registro na ANVISA

Medicamento	Classe terapêutica	Registro na ANVISA	Situação
Omalizumabe	Outros antialérgicos	SIM	Ativo

V. Risco iminente à vida

Não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida da paciente.

VI. Atendimento ou procura prévia da rede pública

Não consta nos autos informação de atendimento ou procura prévia da rede pública local relacionada à presente demanda.

VII. Disponibilidade no SUS

O Omalizumabe não está incorporado na RENAME 2024 ou em outro ato normativo do SUS para a CID da requerente. Está incorporado ao SUS pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento da Asma (CID-10 J45.0 e J45.8), na apresentação de 150 mg/mL, solução injetável em seringa preenchida, mediante os critérios do PCDT específico, patologia diferente da apresentada pela requerente.

Não há em tramitação solicitação de avaliação do Omalizumabe para a patologia/CID apresentada, conforme a consulta pública a que este Núcleo tem acesso (tecnologias em avaliação na CONITEC).

VIII. Ente responsável

Como o Omalizumabe não está incorporado para a CID apresentada, não é possível indicar ente público responsável segundo as normas do SUS.

IX. Alternativas existentes no SUS

A RENAME 2024 tem incorporados no Componente Básico (CBAF) anti-histamínicos sistêmicos (Dexclorfeniramina, Loratadina, Prometazina) e corticosteroides sistêmicos (Dexametasona, Prednisolona, Prednisona e Hidrocortisona).

X. Genérico e preço

O Omalizumabe não tem genérico ou similar. Preço conforme tabela CMED/ANVISA (PF: preço de fábrica; PMC: preço máximo ao consumidor; PMVG: preço máximo de venda ao governo), alíquota 17%, consultado em 26/03/2026:

- OMLYCLO (CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA) 150 MG/ML SOL INJ SC CT 1 SER PREENC VD

TRANS C/ PROT ESP AGU X 0,5 ML; PF: R$ 1.484,66; PMC: R$ 2.052,45; PMVG: R$ 1.165,01.

XI. Conclusão

- Não consta nos autos informação de atendimento ou procura prévia da rede pública local relacionada à demanda, e não há dados clínicos de risco iminente à vida.
- O Omalizumabe não está incorporado na RENAME 2024 ou em outro ato normativo do SUS para a CID da requerente; está incorporado no CEAF apenas para Asma (CID-10 J45.0 e J45.8).
- Não há em tramitação solicitação de avaliação do Omalizumabe na CONITEC para a patologia/CID apresentada.
- A RENAME 2024 tem anti-histamínicos e corticosteroides sistêmicos no CBAF.
- Diretrizes nacionais e internacionais orientam a decisão clínica, mas não têm, isoladamente, a robustez metodológica de ensaios clínicos randomizados ou meta-análises e não substituem evidência científica de alta qualidade, sobretudo em contextos regulatórios e judiciais.
- Para medicamentos não incorporados devem ser observados eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário, conforme os Temas 6 e 1.234 do STF. No caso, não foram apresentadas evidências científicas robustas, em sua integralidade, que demonstrem segurança e desfechos clínicos adequados à condição específica da paciente.

Em face do exposto, este Núcleo de Apoio Técnico manifesta-se **desfavorável** ao pedido de Omalizumabe.

26 de março de 2026.

Equipe técnica do NATJus (médicos, farmacêuticos e enfermeiros)
assinado por certificação digital